UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Projeto Integrador e Prática Profissional II — 2026.2

RELATÓRIO PARCIAL 1

Problema e Requisitos do Sistema

Checkpoint 1 — 09 de outubro de 2026

Campo	Preencher
Nome da equipe	Equipe SIGA-SUS
Turma	( ) Virtual ADS 7 (X) Virtual ADS 8
Nome do sistema	SIGA-SUS
Link do repositório	https://github.com/JohnataRuan/SIGASUS
Data de entrega	09/10/2026

1. Identificação da equipe

Nome completo	Usuário no GitHub	Papel principal nesta etapa
Johnata Ruan Nogueira Souto Santos	@JohnataRuan	Início do projeto; validação e direcionamento por CEP; funções principais
Fernanda Ramos Silva	@fernandaramosllv	Apresentação inicial, bônus e conclusão
Lucas Antônio Evaristo Costa	@Yun-Kazo	Etapas do sistema e triagem
Anna Laura de Lima Silva	@LauraDeveloper	Objetivo do sistema e público atendido; finalização do projeto

2. O problema

2.1. Contexto

O SIGA-SUS busca apoiar a organização do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), com foco em agendamento, triagem, filas e definição de prioridades. A versão atual usa Python e tecnologias web, sem banco de dados.

2.2. Quem é afetado

Os principais afetados são pacientes, recepcionistas e profissionais das UBS. Pacientes podem esperar por longos períodos; a equipe organiza filas, fichas e prioridades.

2.3. Como o problema é resolvido hoje, sem o sistema

Atualmente, o atendimento ocorre em grande parte presencialmente, com filas e fichas; informações também podem ser anotadas manualmente ou em planilhas. Isso pode dificultar a consulta dos dados e a organização dos encaminhamentos. Os procedimentos podem variar entre unidades.

2.4. Consequências do problema

A situação pode gerar espera prolongada, deslocamentos desnecessários, perda de tempo e retrabalho, além de dificultar a identificação de prioridades. Não foram fornecidos números para quantificar essas consequências.

3. De onde vieram as informações

Pessoa consultada	Papel / relação com o problema	Data	Como foi (presencial, chamada, mensagem)
Lucimar Ramos	Assistente social; vivencia dificuldades relacionadas à demora e à organização dos atendimentos	10/09/2026	Conversa presencial

3.1. Principais coisas que aprendemos nessas conversas

1. A demora e a organização do atendimento são dificuldades relevantes.
2. A triagem deve considerar sintomas e prioridade.
3. O CEP pode apoiar o direcionamento à UBS mapeada.
4. Dados inválidos podem impedir o cadastro.
5. O sistema apoia o fluxo, mas não substitui profissionais de saúde.

4. Objetivo do sistema

4.1. Objetivo geral

Apoiar pacientes na busca por atendimento em UBS, reunindo dados cadastrais, sintomas informados, indicação de prioridade de triagem e direcionamento por CEP, conforme as funções disponíveis.

4.2. Objetivos específicos

• Cadastrar e validar os dados do paciente.
• Registrar sintomas para apoiar a triagem.
• Apresentar o nível de prioridade indicado.
• Relacionar o CEP à UBS mapeada.
• Apresentar resumo do encaminhamento e comprovante, quando disponível.

5. Escopo

O sistema VAI fazer	O sistema NÃO vai fazer
Cadastrar informações do paciente e validar dados informados.	Controlar estoque de farmácia.
Receber sintomas informados e indicar um nível de prioridade para triagem.	Cobrar taxas ou realizar pagamentos.
Relacionar o CEP informado à UBS correspondente no mapeamento disponível.	Substituir avaliação profissional, emitir diagnóstico ou prescrever exames e medicamentos.
Apoiar o agendamento e apresentar a confirmação do atendimento.	Garantir atendimento imediato ou disponibilidade real de vagas na UBS.
Organizar informações de triagem e encaminhamento.	Manter banco de dados relacional, pois a versão atual não utiliza um.

6. Usuários do sistema

Tipo de usuário	Descrição	O que faz no sistema
Paciente	Pessoa que informa seus dados e sintomas para buscar orientação de atendimento.	Realiza o cadastro, informa sintomas e CEP, consulta a prioridade indicada e recebe informações do encaminhamento.

7. Requisitos funcionais

Código	Descrição do requisito	Prioridade	Origem
RF01	O sistema deve cadastrar o paciente e validar CPF e Cartão SUS (CNS).	Essencial	Descrição do projeto
RF02	O sistema deve permitir que o paciente informe os sintomas apresentados.	Essencial	Descrição do projeto
RF03	O sistema deve classificar a triagem por cores de prioridade: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul.	Essencial	Descrição do projeto

Código	Descrição do requisito	Prioridade	Origem
RF04	O sistema deve apresentar o nível de urgência indicado para o atendimento.	Importante	Descrição do projeto
RF05	O sistema deve relacionar o CEP informado ao mapeamento de UBS disponível.	Essencial	Implementação descrita pela equipe
RF06	O sistema deve indicar a UBS associada ao CEP no mapeamento disponível.	Importante	Implementação descrita pela equipe
RF07	O sistema deve registrar a solicitação de agendamento na UBS indicada e informações de exames previamente indicados por profissional de saúde.	Importante	Descrição do projeto
RF08	O sistema deve apresentar um resumo dos dados e do encaminhamento indicado.	Importante	Descrição do projeto
RF09	O sistema deve gerar comprovante textual com os dados do atendimento, quando disponível.	Desejável	Implementação descrita pela equipe
RF10	O sistema deve informar quando os dados obrigatórios forem inválidos ou insuficientes para continuar.	Importante	Descrição do projeto

8. Critérios de aceite dos requisitos essenciais

Código	Critério de aceite
RF01	Dado que o paciente informa todos os campos obrigatórios válidos, quando confirma o cadastro, então o sistema aceita os dados e prossegue.
RF01	Dado que falta um campo obrigatório ou um identificador não passa na validação, quando o paciente tenta continuar, então o sistema informa o problema e não conclui a operação.
RF02	Dado que o paciente está na etapa de informações de saúde, quando preenche os sintomas e confirma, então o sistema registra as respostas para a triagem.
RF02	Dado que o paciente não informa os sintomas necessários, quando tenta avançar, então o sistema solicita o preenchimento e não trata a informação ausente como resposta válida.
RF03	Dado que os sintomas necessários foram informados, quando o sistema processa a triagem, então apresenta a categoria de prioridade prevista na lógica implementada.
RF03	Dado que as respostas estão incompletas ou não podem ser processadas, quando ocorre a tentativa de classificação, então o sistema informa que não foi possível concluir a classificação.
RF05	Dado que o CEP informado corresponde a uma entrada do mapeamento, quando o sistema consulta o CEP, então apresenta a UBS associada a essa entrada.
RF05	Dado que o CEP está ausente ou não existe no mapeamento, quando o sistema tenta localizar a UBS, então informa que não foi possível determinar a unidade por esse método.

9. Requisitos não funcionais

Código	Descrição	Como vamos verificar
RNF01	O sistema deve informar claramente quando os dados forem inválidos ou insuficientes.	Testar campos vazios e inválidos.
RNF02	O sistema deve manter consistência entre entradas e resultados em cada execução.	Comparar resultados em diferentes testes.
RNF03	O sistema deve usar instruções claras para o preenchimento.	Verificar a compreensão das etapas em teste de uso.
RNF04	O sistema deve executar sem depender de banco de dados.	Executar o projeto sem um SGBD.
RNF05	O sistema não deve apresentar triagem como diagnóstico médico.	Revisar os textos exibidos.

10. Regras de negócio

Código	Regra	Requisitos afetados
RN01	A triagem automatizada não substitui a avaliação profissional.	RF03, RF04
RN02	O direcionamento por CEP depende do mapeamento de UBS disponível.	RF05, RF06
RN03	Dados obrigatórios inválidos impedem a conclusão do cadastro.	RF01, RF10
RN04	A versão atual não controla estoque nem realiza cobranças.	Escopo

11. Tecnologias previstas

Item	Escolha da equipe	Por que escolhemos
Linguagem	Python	Linguagem usada na versão atual.
Banco de dados	Não utiliza banco de dados	A versão atual não usa SGBD.
Ambiente de execução	Execução no ambiente local de desenvolvimento	Permite executar e testar a versão atual.
Controle de versão	Git e GitHub	Registram alterações e compartilham o código.
Outras ferramentas	HTML, CSS e JavaScript	Tecnologias complementares informadas pela equipe.

12. O que faremos até a Entrega 2 (modelagem UML)

Semana	O que vamos fazer	Quem é responsável
12/10 a 16/10	Definir atores e desenhar o diagrama de casos de uso.	Equipe toda

13. Riscos do projeto

Risco	Chance	Impacto	O que faremos se acontecer
Pouco tempo para concluir e revisar as entregas	Alta	Alto	Dividir tarefas por integrante, definir pequenas metas semanais e revisar o andamento em conjunto.
Experiência inicial da equipe em programação	Alta	Médio	Pesquisar a documentação, testar em partes pequenas e compartilhar o que cada integrante aprendeu.
Erros de código ou incompatibilidade entre partes desenvolvidas	Média	Alto	Testar cada alteração, registrar mudanças no Git e reservar tempo para integração e correção.

14. Declaração de uso de inteligência artificial

Quem usou	Ferramenta	Em que parte	Para quê
Anna Laura de Lima Silva	ChatGPT	Organização e redação do relatório.	Organizar e melhorar a clareza do texto com base nas informações fornecidas pela equipe.

15. Referências

Referências: portal oficial do Ministério da Saúde — SUS (https://www.gov.br/saude/pt-br) e materiais informativos sobre atendimento em UBS e triagem consultados pela equipe. Os endereços específicos das demais páginas não foram registrados.

Anexo — Confiram antes de entregar

	Item
(X)	Todas as seções preenchidas, sem linhas de instrução (▸) e sem as linhas de exemplo em cinza
(X)	Requisitos funcionais, numerados e com prioridade
(X)	No máximo metade dos requisitos marcados como Essencial
(X)	Pelo menos uma pessoa real consultada, registrada na seção 3
(X)	A coluna 'O sistema NÃO vai fazer' preenchida
(X)	Todo requisito escrito no formato 'O sistema deve…'
(X)	Todo requisito Essencial com pelo menos dois critérios de aceite, um deles para o caso que o sistema falha
(X)	Nenhum requisito usando a palavra 'gerenciar' sem explicar o que isso significa
(X)	Declaração de uso de IA preenchida
( )	Arquivo em PDF, na pasta /docs do repositório, com o nome relatorio-parcial-1.pdf
( )	Link do repositório enviado no fórum antes do início da aula

Avaliação do Checkpoint 1

Critério	Peso
Clareza do problema e evidência de contato com quem o vive	25%
Qualidade e priorização dos requisitos	30%
Escopo delimitado, com o que fica de fora explicitado	15%
Apresentação e arguição: clareza, domínio do conteúdo, participação de todos	20%
Organização do repositório e do relatório	10%